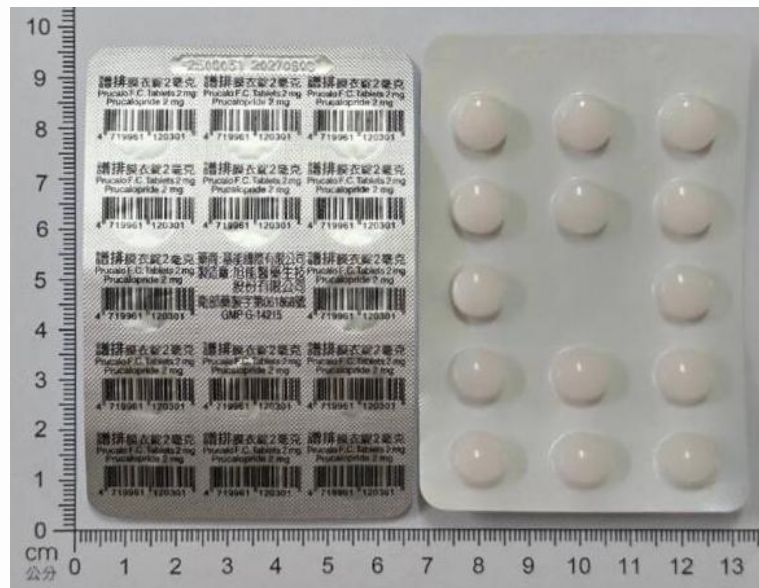


新進藥品評估-案9

Prucalo 2mg/tab 譜排膜衣錠2毫克

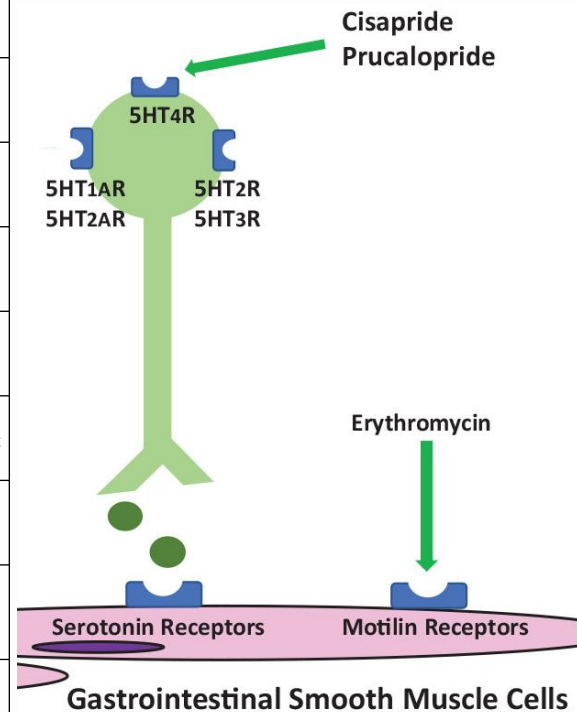


申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Prucalo (Prucalopride)	2mg/tab	Selective 5-HT4 receptor agonist	申請中 / 60元 (自費)	是	• Mopride 5mg/tab • Goofice 5mg • MgO 250mg • Lactulose 600mg/mL • Forlax 10g/pk • Through 12mg/tab • Bisacodyl10mg/supp
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：雙和消化內科 李宗穎醫師)		
適用於使用瀉劑(laxatives)仍無法達到適當緩解效果之成人慢性便秘患者的症狀治療。			• 全台唯一 Prucalopride 成分藥品 • 下腸胃道 5HT4 受體促效劑 • 台灣唯一處方緩瀉劑 • 國際治療指引用藥 • 可長期服用		

療效-指引

First choice for treatment	Osmotic laxatives	MgO , Lactulose , Polyethylene glycol , etc
Second-line treatment	Secretagogues	Lubiprostone, Linaclotide
	IBAT inhibitors	Elobixibat
Alternative / complementary treatment	Probiotics,	<i>Bifidobacterium lactis</i> , etc
	Bulk-forming laxatives	Carboxymethyl cellulose, Calcium polycarbophil
	Prokinetics	Cisapride, Mosapride , Prucalopride , Tegaserod, etc
	Kampo medicines	Rhubarb
As-needed rescue treatment	Stimulant laxatives	Sennosides , Bisacodyl
申請藥品 ; 院內藥品 ; IBAT: Ileal Bile Acid Transporter		



療效/安全性-文獻

Goyal, et al. *Aliment Pharmacol Ther*, 2026)

- Prospective, open-label study with blinded outcome assessment
- Patients aged 18 – 80 years, who meet Rome IV criteria of functional constipation, to receive treatment for 8 weeks:
 1. Elobixibat 10mg QD
 2. Prucalopride 2mg QD

Rescue medication with bisacodyl was allowed if no bowel movement had occurred for 72 h or longer.

		Elobixat (n=108)	Prucalopride (n=106)	P-value
CSBM within 24 h after first dose, n(%)		48 (44.8)	25 (23.6)	0.009
Time to first CSBM, h		7:20 (06:45–25:15)	13:30 (04:55–26:40)	0.003
At 8 weeks	Mean CSBM/week	3.5 ± 2.2	2.8 ± 1.8	0.011
	Change in number of CSBM/week from baseline	2.5 ± 1.9	1.8 ± 1.6	0.004
	≥3 CSMBs/week, %	55.56	33.96	0.024
PAC-QoL score at 8 weeks	Physical discomfort	4.5	4.7	-
	Psychosocial discomfort	6.2	6.6	-
	Worries and concerns	10.5	13.8	-
	Dissatisfaction	5.4	6.3	-
	Total score	27.3 ± 12.4	31.6 ± 10.9	0.009
	Change in score	-9.3 ± 10.9	-4.6 ± 8.6	0.006
Adverse events	Patients with ≥1 AE	11 (10.2%)	9 (8.5%)	-
	Discontinued due to AE	1 (0.009%)	0 (0.00%)	-
	AEs reported	14 (12.9%)	12 (11.3%)	-
	Abdominal pain	7 (6.5%)	3 (2.8%)	-
	Diarrhoea	5 (4.6%)	3 (2.8%)	-
	Abdominal distension	3 (2.7%)	4 (3.8%)	-
	Dyspepsia	2 (1.8%)	2 (1.9%)	-

同類藥品比較

	申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
藥名	Prucalo 2mg/tab (Prucalopride)	Goofice 5mg/tab (Elobixibat)	Mopride 5mg/tab (Mosapride)
適應症	適用於使用瀉劑仍無法達到適當緩解效果之成人慢性便秘患者的症狀治療。	適用於治療成人之慢性功能性便秘(不包含與器質性疾病相關的便秘)。	消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。
角色	• Selective 5-HT4 receptor agonist • 作用於腸道，用於緩解便秘，於指引中屬於complementary treatment	• IBAT inhibitor • 用於緩解便秘，於指引中屬於second line treatment	• Selective 5-HT4 receptor agonist • 作用於上消化道，用於加速胃排空
建議劑量	2mg QD	10mg QD	5mg TID
健保價	申請中 / 60元 (自費)	NA / 35元 (自費)	2 元
每日藥價	60元	70元	6 元
月均用量	NA	1,239 (115Q1新進)	265,644

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Prucalo 2mg/tab (Prucalopride)	Goofice 5mg/tab (Elobixibat)	Mopride 5mg/tab (Mosapride)
主要開立科別：消化內科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	消化內科：Prucalopride 在指引中屬於二、三線用藥了，適用族群應該不大，如果可以增加武器當然最好，但是若需取代的話，沒有非常有必要，尊重藥委會決議。	臨床療效無明顯優勢
萬芳	消化內科：Prucalopride和 eloxibat的機轉不同，對於難以控制的便秘病人，能夠以兩種機轉、低劑量治療會比將一個pathway用到沒效還要好，但就實際面而言，一顆35已經有點難推，一顆60可能市場更小。希望進用，但若必須二擇一，傾向保留eloxibat。	有最新醫療研究結果說Elobixibat優於Prucalopride (PMID: 42387275)
雙和	消化內科：兩個藥品雖然都屬於後線自費藥品，但是Prucalopride 的市場包含歐美，在較多指引、文獻中有探討，而且兩者機轉不相同，contraindication不同。使用上可能會優先考慮開立Goofice，但兩者也可以併用，希望進用，但不同意取代 Goofice。	無意見，依臨床科意見為主

綜合評估

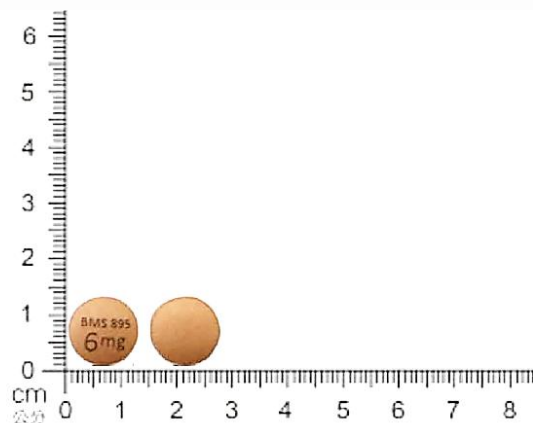
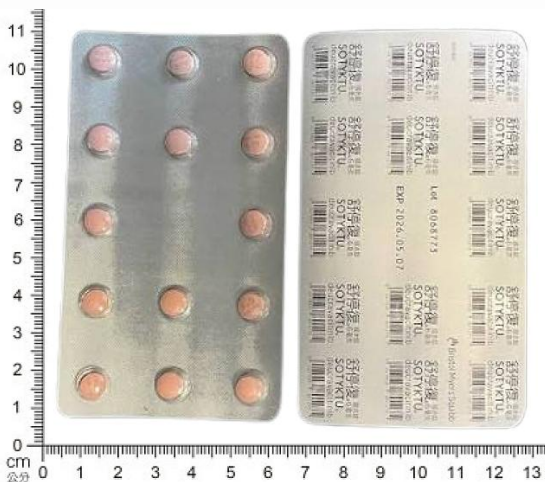
申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Prucalo 2mg/tab (Prucalopride)	Goofice 5mg/tab (Elobixibat)	Mopride 5mg/tab (Mosapride)

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品 (院內有適應症不相同的 同機轉藥品)	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求
國內同儕使用經驗 (北馬、花慈、高榮)	體系有使用經驗	臨床需求共識度 (如需取代、傾向保留 現有品項)	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	包裝外觀相似：Famvir、Rancad	
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. 院內已有多項第一線慢性便秘用藥 (如 MgO、Lactulose) 及 rescue 用藥 (如 Through、Bisacodyl)，至於後線慢性便秘用藥，此品項的效果及治療定位不如 eloxibat (於115年度Q2進用)。 2. 雖然機轉與 eloxibat 不同、兩者可以併用，但兩者皆為自費藥品，併用的需求不高。 3. 考量療效與處方順位不如院內品項，建議不通過 Prucalo。			

建議通過	建議比價	建議不通過
		✓

新進藥品評估-案15

Sotyktu film-coated tablets 舒停復膜衣錠6毫克



申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Sotyktu 舒停復膜衣錠 (Deucravacitinib)	6mg / Tab	Tyrosine kinase 2 inhibitor	396 元	否 (全新藥理機轉)	Otezla 10mg,20mg,30mg (Apremilast)
衛福部適應症		申請理由(提藥醫師：葛芳皮膚科 沈孟暎醫師)			
適用於治療適合全身性療法或光照療法的中度至重度成人斑塊型乾癬。		- 新成分新機轉新藥：Sotyktu 是目前具乾癬適應症的口服用藥中，第一個機轉屬於是 TYK2 inhibitors。 - 健保給付地位特殊：對於肝腎功能不佳的中重度乾癬患者屬於必備用藥，且屬於生物製劑使用前或停藥後延續治療的口服用藥。 - 療效安全性皆優於目前的口服用藥：具 head to head 或 meta-analysis 資料佐證，療效安全性皆優於目前 csDMARDs。			

療效-機轉

TYK2 Pathway

Type I IFN α , β



- Dendritic cell maturation
- B cell differentiation
- Antibody production
- T cell survival
- MHC expression

IL-23, IL-12



- Th1 differentiation
- Th17 differentiation
- ILC activation
- Dendritic cell activation
- IL-17, TNF α , and IFN γ secretion

JAK1-3 Pathway

IFN γ , IL-6



- Osteoclast formation
- Th1 differentiation
- Neuronal survival
- Lipid metabolism
- Granulopoiesis

IL-2, IL-4, IL-7, IL-9,
IL-15, IL-21

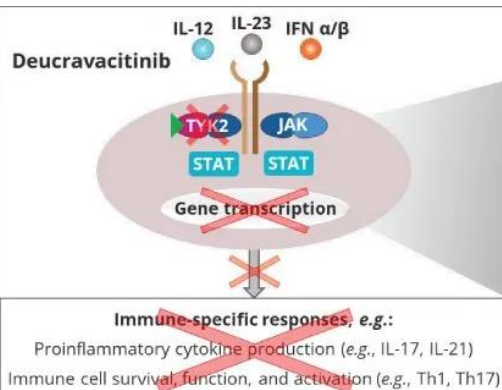


- Lymphoid cell maturation and function
- T cell survival
- Th2 differentiation
- Treg maintenance

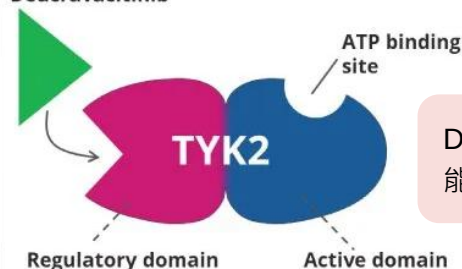
EPO, leptin, GM-CSF,
GH, TPO, prolactin



- Hematopoiesis
- Growth factor response
- Metabolic activity regulation
- Myelopoiesis



Deucravacitinib

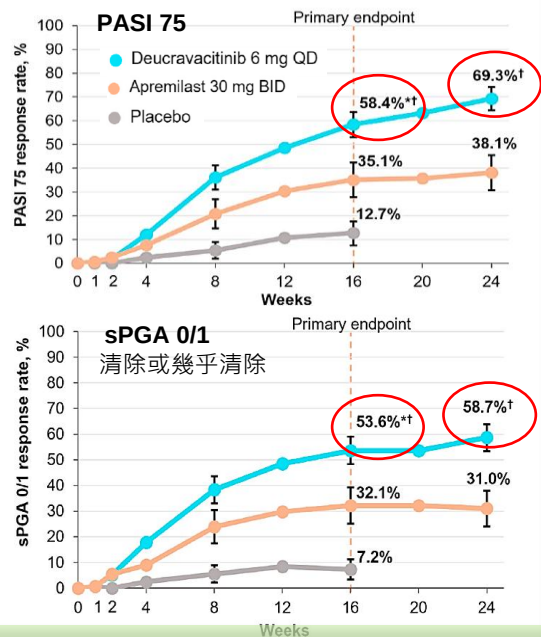


Deucravacitinib 對 TYK2 enzyme 具高度專一性
能阻斷 IL-23、IL-12、IFN 的訊號傳遞，調節發炎反應

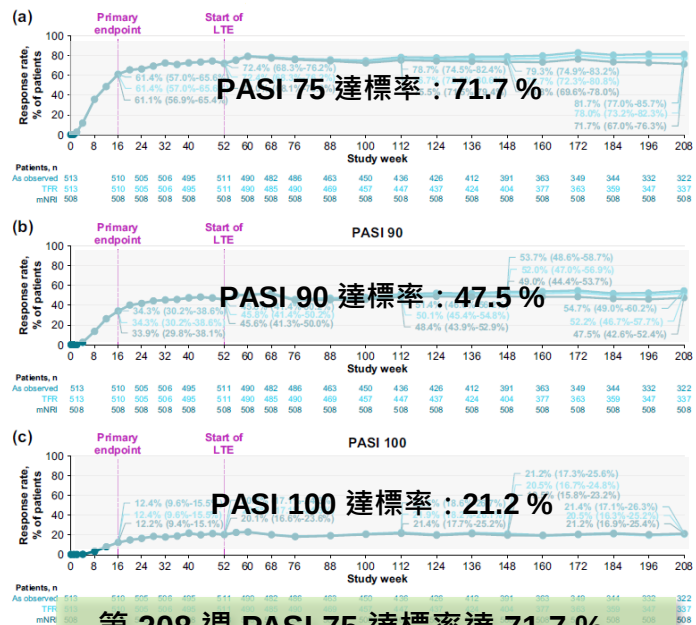
療效-文獻

April W. Armstrong, et al (JEADV, 2025) - POETYK PSO-1/-2(1年) + Long-Term Extension Trial(3年) · 共 208 週

- POETYK : 52-week, double-blinded, phase 3 trial, enrolling a total of 1,686 patients with moderate-to-severe plaque psoriasis
- Randomized 2:1:1 to deucravacitinib 6 mg QD, apremilast 30mg BID or placebo



療效：Deucravacitinib >> Apremilast



第 208 週 PASI 75 達標率達 71.7 %，
PASI 90 達 47.5 %，長期療效穩定

安全性-同類品, Placebo

Deucravacitinib vs. Apremilast vs. Placebo 一年期

Most common :

- **Deucravacitinib** 呼吸道感染、鼻咽炎
- Apremilast 腹瀉、頭痛

SAEs : 未見異常嚴重安全警訊

Discontinuation : **Deucravacitinib** 耐受性最佳

Herpes zoster : 發生率均極低 (<1%)

MACE、VTE : 未見異常風險訊號

Deucravacitinib 四年期

AEs & Discontinuation : 隨時間遞減

Herpes zoster : 隨時間微幅降低(EAIR 0.81 → 0.55)

SAEs, Deaths, MACE, VTE : **未見累積性毒性或安全警訊**

TABLE 2 Cumulative safety summary through 1 year and 4 years (as-treated population).

AE category	Cumulative through 1 year ^a (POETYK PSO-1 + PSO-2)						Cumulative through 4 years ^b (POETYK PSO-1 + PSO-2 + LTE)	
	Placebo (n = 666)		Apremilast 30 mg BID (n = 422)		Deucravacitinib (n = 1364)		Deucravacitinib (n = 1519)	
	Total PY = 240.9		Total PY = 221.1		Total PY = 969.0		Total PY = 4392.8	
	1-Year cumulative, n (%)	EAIR/100 PY (95% CI)	1-Year cumulative, n (%)	EAIR/100 PY (95% CI)	1-Year cumulative, n (%)	EAIR/100 PY (95% CI)	4-Year cumulative, n (%)	EAIR/100 PY (95% CI)
AEs	347 (52.1)	217.37 (195.66–241.49)	299 (70.9)	281.06 (250.94–314.79)	995 (72.9)	229.23 (215.42–243.93)	1301 (85.6)	131.68 (124.62–139.03)
SAEs	14 (2.1)	5.66 (3.35–9.55)	9 (2.1)	4.01 (2.09–7.71)	55 (4.0)	5.68 (4.36–7.39)	205 (13.5)	5.01 (4.35–5.75)
Discontinued treatment due to AEs	23 (3.5)	9.31 (6.18–14.01)	26 (6.2)	11.64 (7.93–17.10)	43 (3.2)	4.38 (3.25–5.91)	97 (6.4)	2.20 (1.78–2.68)
Deaths	1 (0.2)	0.40 (0.06–2.84)	1 (0.2)	0.44 (0.06–3.14)	2 (0.1) ^c	0.20 (0.05–0.81)	11 (0.7) ^d	0.25 (0.12–0.44)
Most common AEs (EAIR ≥5/100 PY)								
Nasopharyngitis	54 (8.1)	22.72 (17.40–29.66)	54 (12.8)	25.95 (19.87–33.88)	229 (16.8)	26.14 (22.97–29.76)	343 (22.6)	9.72 (8.72–10.81)
Upper respiratory tract infection	33 (5.0)	13.54 (9.63–19.05)	27 (6.4)	12.37 (8.48–18.03)	124 (9.1)	13.42 (11.25–16.00)	240 (15.8)	6.11 (5.36–6.94)
Headache	21 (3.2)	8.56 (5.58–13.12)	53 (12.6)	25.98 (19.85–34.01)	80 (5.9)	8.47 (6.81–10.55)	117 (7.7)	2.83 (2.34–3.39)
Diarrhoea	28 (4.2)	11.51 (7.95–16.67)	54 (12.8)	26.48 (20.28–34.58)	69 (5.1)	7.27 (5.75–9.21)	99 (6.5)	2.36 (1.92–2.87)
Arthralgia	21 (3.2)	8.55 (5.57–13.11)	17 (4.0)	7.66 (4.76–12.32)	55 (4.0)	5.71 (4.38–7.43)	117 (7.7)	2.80 (2.32–3.36)
COVID-19 ^e	2 (0.3)	0.80 (0.20–3.20)	0	0	5 (0.4)	0.51 (0.21–1.22)	321 (21.1)	8.29 (7.41–9.25)
Serious infections	2 (0.30)	0.80 (0.20–3.20)	4 (0.95)	1.78 (0.67–4.73)	17 (1.25)	1.73 (1.08–2.79)	85 (5.60)	1.99 (1.59–2.46)
Serious COVID-19/ COVID-19 pneumonia	0	0	1 (0.24)	0.44 (0.01–2.46)	2 (0.15)	0.20 (0.02–0.73)	54 (3.55)	1.25 (0.94–1.63)
Serious infections excluding COVID-19	2 (0.30)	0.80 (0.10–2.89)	3 (0.71)	1.33 (0.27–3.89)	15 (1.10)	1.53 (0.86–2.52)	35 (2.30)	0.80 (0.56–1.11)
Herpes zoster								
Herpes zoster ^f	1 (0.2)	0.40 (0.06–2.84)	0	0	8 (0.6)	0.81 (0.41–1.63)	24 (1.6)	0.55 (0.35–0.82)
Ophthalmic herpes zoster ^g	0	0	0	0	1 (0.1)	0.10 (0.01–0.72)	1 (0.1)	0.02 (0.0–0.13)
MACE ^h	3 (0.5)	1.20 (0.39–3.73)	2 (0.5)	0.89 (0.22–3.54)	3 (0.2)	0.30 (0.10–0.94)	14 (0.9)	0.32 (0.17–0.53)
VTE ⁱ	0	0	0	0	2 (0.1)	0.20 (0.05–0.81)	3 (0.2)	0.07 (0.01–0.20)

藥品比較

	申請藥品	暫定取代藥品
藥名	Sotyktu 6mg (Deucravacitinab)	Otezla 10mg, 20mg, 30mg (Apremilast)
適應症	成人PsO	成人/ 兒童PsO, PsA, 貝西氏症相關的口腔潰瘍
差異	• Tyrosine Kinase 2 Inhibitor • 實證顯示 PsO 療效優於 Apremilast • 常見副作用：呼吸道感染、鼻咽炎 • 不須依腎功能調整劑量，重度肝功能不全不建議使用	• Phosphodiesterase - 4 Inhibitor • 常見副作用：腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛 • 須依腎功能調整劑量，不須依肝功能調整劑量 • 預計於 115 年 12 月 31 日 停止供應
建議劑量	6mg QD	LD 10 – 20mg · MD 30mg BID *兒童劑量依據體重
健保給付	• 傳統全身性治療反應不佳的下一個治療選擇：傳統全身性治療必須包括照光治療 及 MTX 或 cyclosporine 至少一種。 • 申請健保使用生物製劑前的治療選擇： • 肝腎功能正常者：治療必須包括照光治療及系統性治療至少兩種(MTX、acitretin、cyclosporin、apremilast、deucravacitinib) • 肝腎功能不佳者：須先經照光及使用 apremilast 或 deucravacitinib 無效。	
健保價	396 元	64 / 129 / 171 元
每日藥價	396 元	342 元
月均用量	0 / 19 / 51 (T/W/S)	10mg : 2 / 20mg : 2 / 30mg : 234

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Sotyktu (Deucravacitinib)	否 (全新藥理機轉)	Otezla 10mg,20mg,30mg (Apremilast)
主要開立科別：皮膚科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	皮膚科：為提申請之科別，不另行詢問。	Sotyktu 療效優於 Otezla。
萬芳	皮膚科：為提申請之科別，不另行詢問。	Sotyktu 為新機轉口服藥，在中重度乾癬使用傳統全身性治療失敗病人，與生物製劑皆為第一線藥物選擇。
雙和	皮膚科：為提申請之科別，不另行詢問。	Sotyktu 為首個 PsO 選擇性 TYK2 口服藥，可補足 Otezla 停供後之口服治療需求。

綜合評估

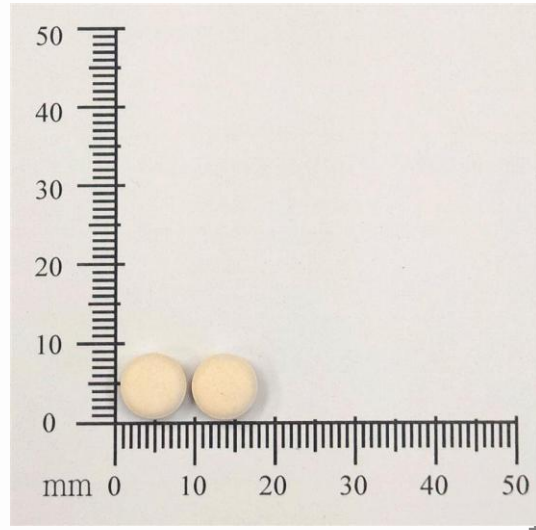
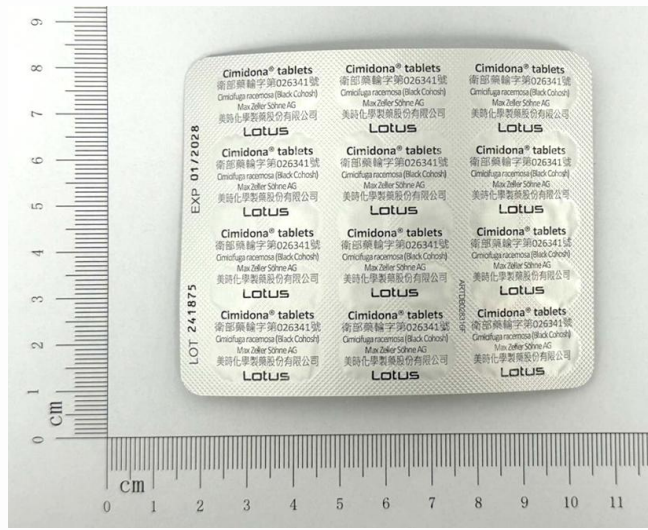
申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Sotyktu (Deucravacitinib)	否 (全新藥理機轉)	Otezla 10mg,20mg,30mg (Apremilast)

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品 (新機轉)	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求 (新機轉口服藥)
國內同儕使用經驗 (台大、長庚、北榮)	體系有使用經驗 (W.S)	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	NA	
歷年審議結果 (年份/不通過原因)	113年/ Sotyktu 為自費藥品，建議有健保價再議			
綜合意見	1. Deucravacitinib 為新機轉口服乾癬治療藥物，實證顯示乾癬療效優於Apremilast，且安全性與耐受性佳。 2. Deucravacitinib 為肝腎功能異常者申請健保生物製劑前的口服藥物必備選項。 3. 現有品項 Apremilast 預計於115年12月停產，為確保乾癬病患治療延續性，建議通過新進Sotyktu。			

建議通過	建議比價	建議不通過
		

新進藥品評估-案17

Cimidona Tablets 喜婦寧錠6.5毫克



申請總表

藥名 (學名)	劑量/ 劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Cimidona Tablets 喜婦寧錠 (Cimicifuga racemosa 黑升麻, Ze 450)	6.5 mg / Tab	機轉仍未有定論 (透過中樞神經傳導物質 調節下視丘體溫中樞)	NA / 30 元 / 粒(自費)	否 (藥理機轉內之第一個 全自費藥品)	NA
衛福部適應症		申請理由(提藥醫師：附醫乳房外科 洪進昇醫師)			
適用於 更年期的常見病症 (熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁以及憂鬱)。		- 台灣唯一核准非賀爾蒙的製劑，緩解更年期等相關症狀。可為雌激素依賴性疾病的患者多提供一項治療選擇。 - 瑞士婦產科醫學會臨床指引與德國癌症患者的輔助療法指引，均有建議乳癌患者，可以使用黑升麻(Black cohosh/ Cimicifuga racemose)緩解其血管舒縮等症狀，如熱潮紅、盜汗等。 - 依據現有的文獻，使用黑升麻並未造成乳癌復發之風險。黑升麻並不會影響CPY2D6，因此不會影響tamoxifen的代謝與藥效。			

療效-指引 | 藥品級標準化黑升麻萃取物

指引 / 族群及症狀	無腫瘤疾病的停經女性 血管舒縮症狀(VMS)	乳癌、接受荷爾蒙治療腫瘤病人 治療相關的血管舒縮症狀	無腫瘤疾病的停經女性 情緒、憂鬱、睡眠障礙
2026 德奧瑞更年期指引	【可能有益】 開放性推薦(0) / 實證品質低 82%專家共識	未納入指引範疇	實證有限，不應推薦
2025 西班牙更年期學會 血管舒縮症狀治療建議	【輕度症狀植物療法首選】 能安全用於自然停經女性 治療12週後必須回診再評估	【能安全使用】 益處大於風險	
2024 德國癌症補充醫學指引	【可能有益】 (引用2020年更年期指引結論)	【可能有益】 開放性推薦(0) / 實證品質中 >95%專家共識	
指引建議	• 可考慮作為改善停經女性VMS(熱潮紅、盜汗)之非荷爾蒙藥物選擇 • 開放性治療選擇，醫師與患者具彈性討論空間 • 建議治療 12 週後回診覆評療效與耐受度		

療效-文獻 *Cimicifuga racemosa* extract Ze 450

Ruediger Schellenberg, et al

(Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012)

- A Multicenter, double-blind RCT, 180 menopausal women
- Ze 450 13mg(HD), Ze 450 6.5mg(LD), placebo for **12 weeks**

症狀嚴重度	PLA	LD	HD	KMI 改善度 (12週)
輕度	+12.2	-5.4	-10.5	HD ≈ LD > PLA
中度	+0.6	-9.6	-17.8	HD > LD > PLA
重度	-4.8	-5.8	-20.1	HD > LD ≈ PLA

生理階段	PLA	LD	HD	KMI 改善度(12週)
未停經	-1.1	-0.2	-20.9	HD > LD ≈ PLA
停經未滿五年	+3.3	-11.0	-17.2	HD > LD > PLA
停經五年以上	+1.5	-10.2	-13.6	HD ≈ LD > PLA

- 輕度 / 停經晚期 (≥5年) → **6.5 mg/day**(最低有效劑量)
- 中度 / 停經早期 (<5年) → 可階梯式調整(具劑量依賴性)
- 重度 / 未停經 → **13 mg/day**

Juergen Drewe, et al (Phytomedicine 20, 2013)

- An open, prospective observational study in 372 adult women with menopausal complaints receiving Ze 450 therapy for **9 months**

KMI 項目	0-3個月 Ze 450 13 mg	4-9個月	
		13 mg (n=228)	6.5 mg (n=102)
熱潮紅	顯著改善*	持續顯著改善*	無顯著改善
夜間盜汗			
關節肌肉痛			
眩暈			
頭痛			
心悸			
失眠			持續顯著改善*
緊張			
憂鬱情緒			
疲倦無力			

建議每 3 個月評估療效反應・並階梯式調整劑量

安全性-文獻 藥品級標準化黑升麻萃取物(Ze 450, iCR)

Ze 450 (60% 乙醇)		General	Liver	Estrogen-Sensitive Organs
Ruediger Schellenberg (2012)	RCT 3 months n=180	SAEs : 0 Treatment related : 4 Common : GI discomfort	ALT, AST↑ : 2	未納入安全探討範疇
Juergen Drewe (2013)	Real-world 9 months n = 372	AEs : 18 Common : GI discomfort	0 case	
Lena Friederichsen (2020)	Cohort study 1 year Ze 450 : 32 MHT : 142	Metabolic ↔ BW , *metabolic marker (血糖,血脂,胰島素阻抗)	未納入安全探討範疇	
iCR (40% 異丙醇)		General	Liver	Estrogen-Sensitive Organs
C. Castelo-Branco (2021)	Meta-analysis 16 RCTs N=13,096	Metabolic ↔ BW, lipid metabolism Other ↔ CV & renal function	No evidence for hepatotoxicity	Established in healthy women & hormone-sensitive cohorts (乳癌,婦癌,子宮內膜異位症) ↔ E2, FSH, LH, prolactin, SHBG ↔ Endometrial thickness, CA 125, cancer recurrence

藥品級標準化黑升麻萃取物(Ze 450, iCR)於 3~12 個月療程具良好耐受度，
現有文獻在生理代謝、肝臟毒性、雌激素敏感器官方面，未見異常安全風險

醫療科技評估(實證評估&安全規範)

Agency	Key Findings
IQWiG (Germany) 德國醫療品質與效率研究所	• 黑升麻可以用於改善停經前後女性的血管舒縮症狀。 • 基於實證水準不足，黑升麻不應被推薦用於治療更年期女性的情緒波動與憂鬱症狀。 • 納入研究的樣本量較小，對於罕見不良反應(如潛在的肝損傷風險)，目前的 RCTs 數據在仍不足以做出絕對的無風險斷言。
EMA (European-HMPC) 草藥醫藥產品委員會	• HMPC 認定黑升麻製劑可用於治療更年期相關不適，特別是熱潮紅與嚴重盜汗/多汗。 • 未經醫師評估，使用療程不得超過 6 個月【仿單有註記】。 • 現有或曾有肝臟疾病史者應謹慎使用。 • 曾患或正在接受治療的乳癌或其他荷爾蒙依賴型腫瘤患者，未經醫囑評估不可使用。

藥品比較

	申請藥品	同類藥品
藥名	Cimidona Tablets 6.5 mg / Tab (Cimicifuga racemosa extract, Ze 450)	院內無同類藥品
適應症	適用於更年期的常見病症 (熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁以及憂鬱)	
療效	• 非賀爾蒙類藥物，不具備雌激素受體刺激作用 • 實證顯示能改善停經女性血管舒縮症狀 • 建議每 3 個月規律覆評症狀反應，階梯式調整劑量或停藥	
安全性	• 常見副作用：腸胃不適 (腹瀉、脹氣)、噁心 • 尚無直接證據顯示肝毒性風險，但肝臟疾病患者應謹慎評估【仿單：肝功能受損者請勿使用】	
建議劑量	6.5mg ~ 13mg QD	
健保價	NA / 30 元 / 粒 (自費)	
每月藥價	30 ~ 60 元	
月均用量	廠商預估量：80盒 (320盒/年/院)	

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Cimidona Tablets (Cimicifuga racemosa, Ze 450)	否 (藥理機轉內之第一個全自費藥品)	NA
主要開立科別：乳房外科、婦科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	乳房外科：為提申請之科別，不另行詢問。 婦科：尊重藥委會意見 - 在美屬，多數黑升麻製劑均以膳食補充劑型態銷售。 - TFDA 核准為「醫師藥師藥劑生指示藥品」，代表經過完整評估，品質與活性成分的穩定度高於市售一般草藥膳食補充劑。 - Cimidona 主要上市與臨床審核依據為瑞士藥品管理局與歐盟藥品管理局的植物藥上市核准標準，並引進台灣取得 TFDA 藥品證號。 - 該產品在歐、美的屬性不同。但是在台灣卻有取得TFDA許可，它是「醫療級藥品」，不是一般保健食品或健康食品。	有進用需求。
萬芳	乳房外科：為提申請之科別，不另行詢問。 婦科：非賀爾蒙製劑應有潛在使用族群。	屬指示藥品，可於社區藥局購買。
雙和	乳房外科：為提申請之科別，不另行詢問。 婦科：應該會有使用族群，價格若再低一些能減輕病患自費負擔。	非賀爾蒙類藥物，可供乳癌病患緩解停經後症候群選擇。

綜合評估

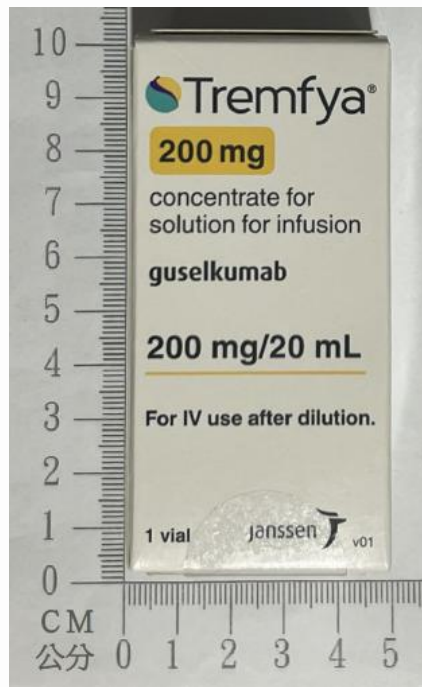
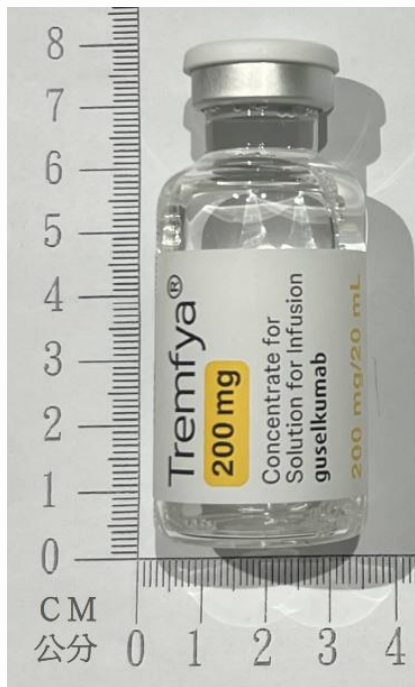
申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Cimidona Tablets (Cimicifuga racemosa, Ze 450)	否 (藥理機轉內之第一個全自費藥品)	NA

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求 (乳癌、接受荷爾蒙治療 腫瘤病人)
國內同儕使用經驗 (三總、馬偕、中山)	體系有使用經驗	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA	藥名相似：Cimzia	
歷年審議結果 (年份/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. Cimidona 為歐洲指引列為改善停經女性血管舒縮症狀(VMS)之非荷爾蒙治療選擇。 2. 針對安全性疑慮，尚無直接證據顯示 Cimidona 具肝毒性風險(肝功能不全者仍應謹慎評估)。 3. Cimidona 可填補賀爾蒙療法禁忌、排斥荷爾蒙療法或停藥過渡期之治療缺口，建議通過新進 Cimidona。			

建議通過	建議比價	建議不通過
		

新進藥品評估-案23

Tremfya Concentrate for Solution for Infusion 200mg/vial 特諾雅靜脈注射液



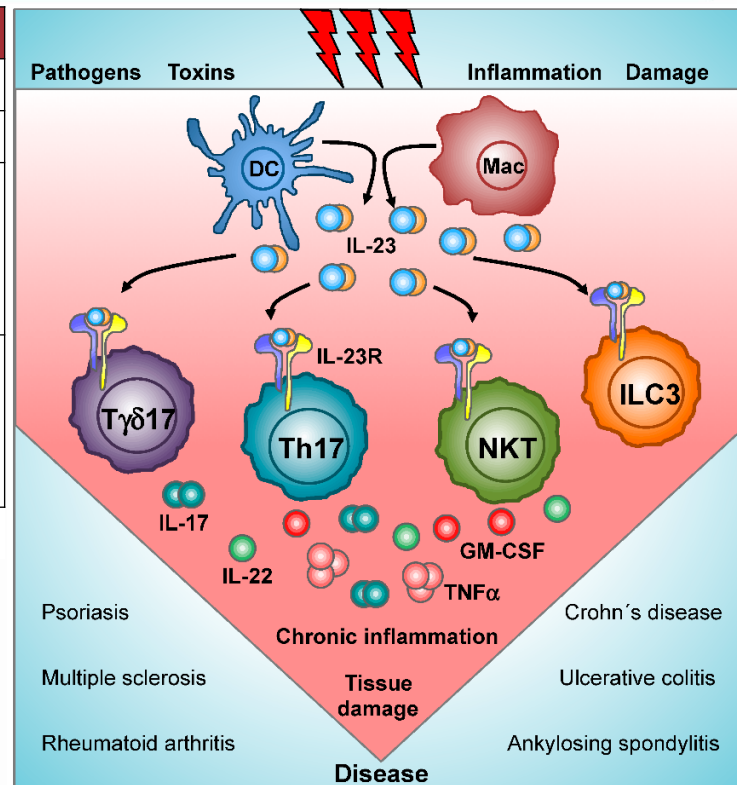
申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Tremfya (Guselkumab)	200mg/vial	Anti-interleukin-23 antibody	申請中 / 40,700元 (自費)	否 (ATC碼相同，但劑 型不同)	- Tremfya 100mg/1mL/pen - Skyrizi 150mg/1mL/pen - Entyvio 300mg/vial
衛福部適應症		申請理由(提藥醫師：萬芳消化內科 張智翔醫師)			
- 對傳統或生物製劑治療反應不佳、失去反應、或無法耐受的中度至重度活動性潰瘍性結腸炎(Ulcerative colitis)成人病人 - 對傳統或生物製劑治療反應不佳、失去反應、或無法耐受的中度至重度活動性克隆氏症(Crohn's disease)成人病人		- 本院目前UC/CD病人於抗TNF製劑或Vedolizumab治療失敗後，後續治療選擇有限。Tremfya(Guselkumab)為具充分臨床證據支持之IL-23抑制劑，兼具療效與良好安全性，可提供不同作用機轉之治療選擇，滿足未被滿足的臨床需求。 - 納入Tremfya後，可完善本院IBD治療布局，降低病人因治療選擇不足而轉院之情形，並有助於減少疾病惡化、住院及手術相關醫療負擔。對於需長期治療之UC/CD病人而言，Tremfya為兼顧療效、安全性與照護品質的重要治療選項，建議納入本院正式品項。			

療效-機轉

Indications	Induction	Maintenance
Plaque psoriasis	✓ SQ: 100 mg at weeks 0, 4	✓ SQ: 100 mg Q8W
Psoriatic arthritis	✓ SQ: 100 mg at weeks 0, 4	✓ SQ: 100 mg Q8W
Crohn disease (moderate – severe)	• IV: 200 mg on weeks 0, 4, and 8. • SQ: 400 mg (2*200mg) on weeks 0, 4, and 8.	✓ SQ: 100 mg Q8W from week 16 • SQ: 200 mg Q4W from week 12
Ulcerative colitis (moderate – severe)	• IV: 200 mg on weeks 0, 4, and 8. • SQ: 400 mg (2*200mg) on weeks 0, 4, and 8.	✓ SQ: 100 mg Q8W from week 16 • SQ: 200 mg Q4W from week 12

✓ 院內品項適用 ; **申請品項適用**

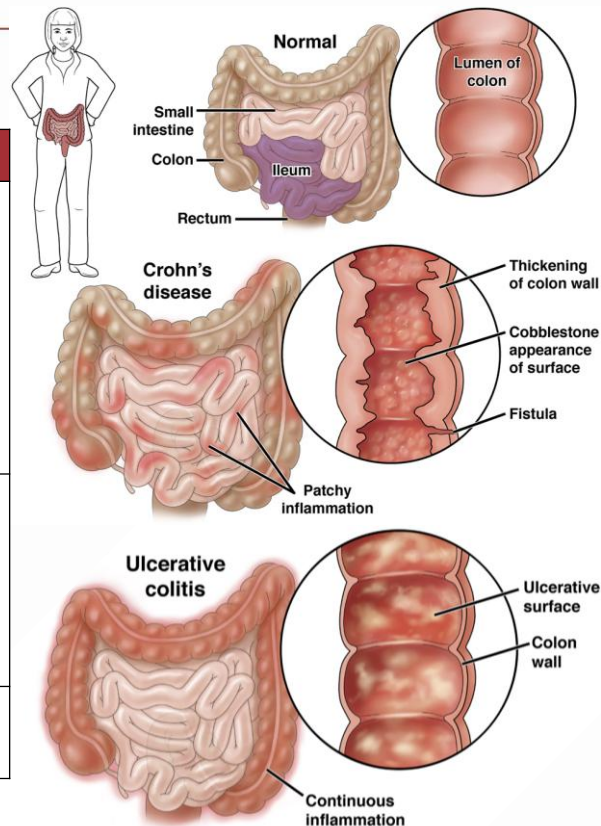


療效-指引

- Recommends **upfront use of higher efficacy** regimens, instead of gradual step-up.
- Switch to higher efficacy regimens of a different drug class if remission was not achieved.

Classification	For UC	For CD
Higher Efficacy	✓ Infliximab (Remsima) ✓ Vedolizumab (Entyvio) • Ozanimod (Zeposia) • Etrasimod (Velsipity) ✓ Upadacitinib (Rinvoq) • Guselkumab (Tremfya)	✓ Infliximab (Remsima) ✓ Adalimumab (Humira / Idacio) ✓ Vedolizumab (Entyvio) • Ustekinumab (Stelara) • Risankizumab (Skyrizi) • Mirikizumab (Omvoh) • Guselkumab (Tremfya)
Intermediate Efficacy	• Mirikizumab (Omvoh) • Ustekinumab (Stelara) ✓ Golimumab (Simponi) ✓ Tofacitinib (Xeljanz) ✓ Filgotinib (Jyseleca)	
Lower Efficacy	✓ Adalimumab (Humira / Idacio)	✓ Certolizumab pegol (Cimzia) ✓ Upadacitinib (Rinvoq)

✓ 院內品項；**申請品項**；與申請品項同藥理作用 (Anti-interleukin agents)



療效/安全性- Crohn's Disease

- GALAXI trial:** 48-week treatment phase 3, randomised, double-blind, triple-dummy, treat-through trials

- Adult patients with moderately to severely active Crohn's disease (≥ 3 months duration)

- Randomization:

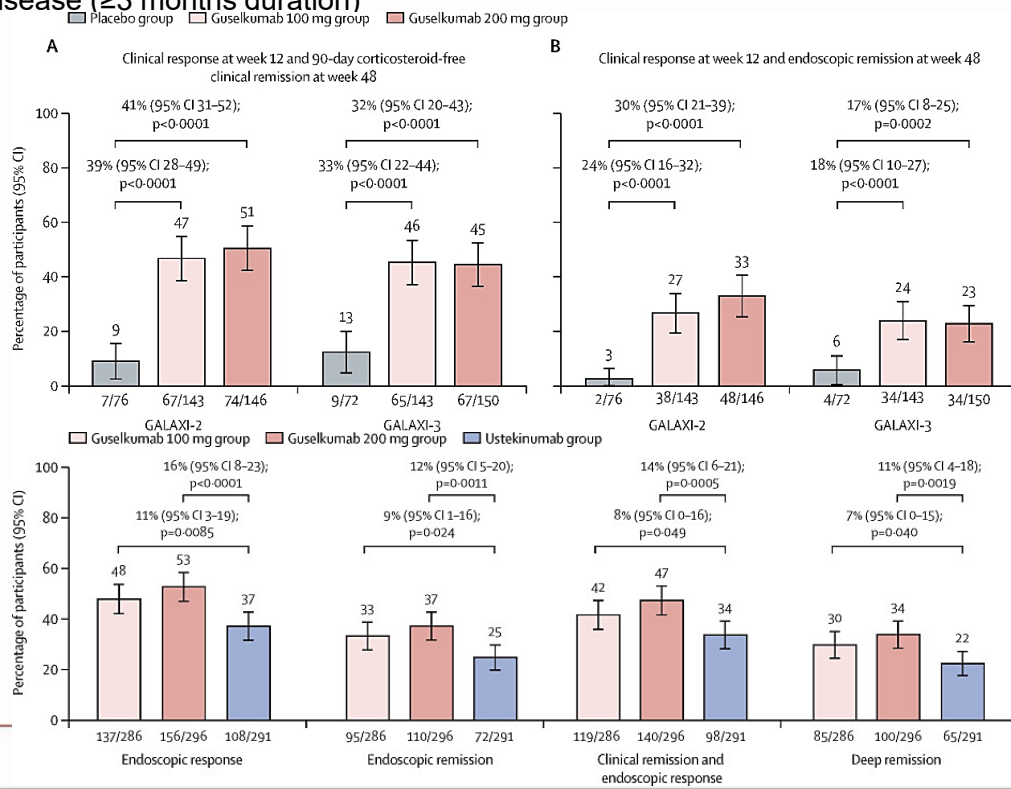
1. **Guselkumab 200 mg IV** at weeks 0, 4, and 8, then **200 mg SQ Q4W** from week 12~44 (n=286)

2. **Guselkumab 200 mg IV** at weeks 0, 4, and 8, then **100 mg SQ Q8W** from week 16~40 (n=296)

3. **Ustekinumab 6 mg/kg IV** at week 0, then 90 mg SQ Q8W from week 8~40 (n=291)

4. **Placebo IV Q4W** at weeks 0, 4, and 8 (n=152)

- Adverse events: respiratory tract infections, abdominal pain, injection site reactions, headache, fatigue, arthralgia, diarrhea, gastroenteritis



療效/安全性- Ulcerative Colitis

- **QUASAR**: randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 induction and phase 3 maintenance study

- Adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis (≥ 3 months duration)

- Induction:

1. **Guselkumab** 200 mg IV at weeks 0, 4, and 8 (n=421)

2. **Placebo** IV Q4W at weeks 0, 4, and 8 (n=280)

- Maintenance:

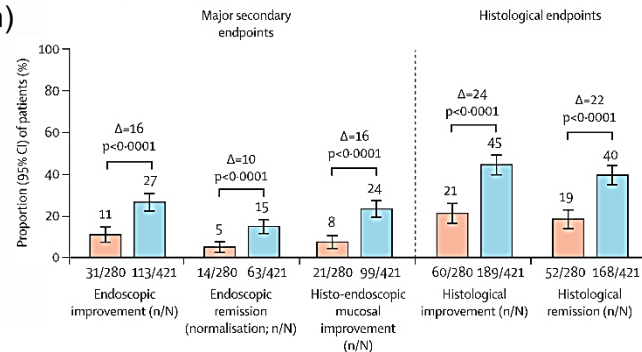
1. **Guselkumab** 200 mg SQ Q4W from week 12~44 (n=190)

2. **Guselkumab** 100 mg SQ Q8W from week 16~40 (n=181)

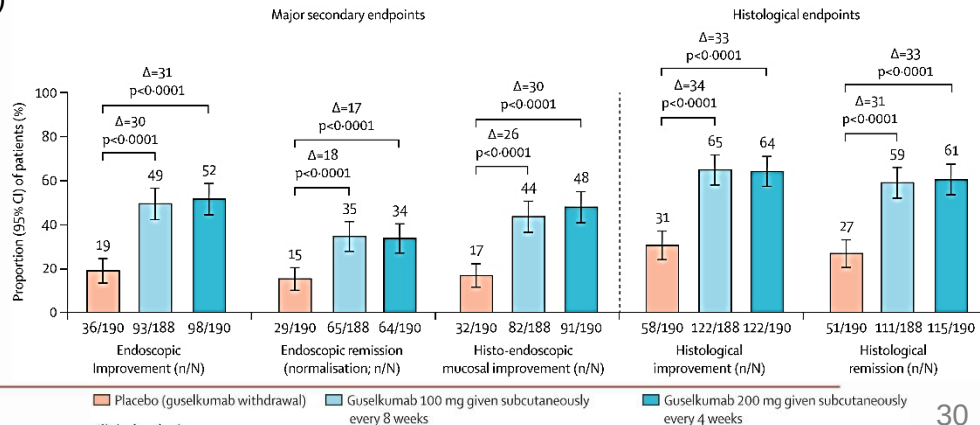
3. **Placebo** IV Q4W at weeks 0, 4, and 8 (n=188)

- Adverse events: injection site reactions, arthralgia, upper respiratory tract infections, headache, gastroenteritis, fatigue, pyrexia, rash

B Endoscopic and histological endpoints



B Endoscopic and histological endpoints



醫療科技評估

Agency	Year	Key Findings
PBAC (Australia)	July 2025	- while Guselkumab was noninferior in terms of effectiveness compared to Ustekinumab for the outcomes of clinical remission and response, it was likely superior in terms of endoscopic outcomes in the maintenance treatment setting - noted the consumer comments regarding the significant quality of life impact severe CD has on patients and the importance of having additional treatment options available, particularly medicines with different mechanisms of action
SMC (Scotland)	Oct 2025	- Results indicated Guselkumab was significantly superior to placebo for the primary outcomes: clinical remission at week 12 (induction) and week 44 (maintenance, QUASAR only). For the secondary outcomes of symptomatic remission and clinical response, results significantly favour guselkumab over placebo. Guselkumab is at least as effective as Risankizumab for the treatment of Crohn's disease, and superior to Ustekinumab for many key endoscopic and clinical measures

同類藥品比較

	申請藥品	同類藥品	同類藥品
藥名	Tremfya 200mg/vial (Guselkumab)	Tremfya 100mg/1mL/pen (Guselkumab)	Entyvio 300mg/vial Entyvio 108mg syringe (Vedolizumab)
機轉	Anti-IL-23 antibody	Anti-IL-23 antibody	Anti-integrin antibody
適應症	- 潰瘍性結腸炎 (induction) - 克隆氏症 (induction)	- 斑塊性乾癬 - 掌蹠膿疱症 - 乾癬性關節炎 - 膿疱性乾癬 - 潰瘍性結腸炎 (maintenance) - 克隆氏症 (maintenance)	- 克隆氏症 - 潰瘍性結腸炎 - 慢性結腸袋炎
建議劑量 (IBD)	Induction: 200 mg IV at weeks 0, 4, and 8	Maintenance: 100 mg SQ Q8W after week 16, or 200 mg SQ Q4W after week 12	Induction: 300mg IV at week 0 and week 2 Maintenance: 300mg IV Q8W or 108mg SQ Q2W after week 6
健保價	申請中 / 40,700元 (自費)	59,973	49,837
每日藥價	1,453.57	1,070.95	1,525.62
月均用量	NA	38	6 (IV) + 10 (SC)

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Tremfya 200mg/vial (Guselkumab)	否 (ATC碼相同，但劑型不同)	- Tremfya 100mg/1mL/pen - Entyvio 300mg/vial
主要開立科別：消化內科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	消化內科： 為提申請之科別，不另行詢問。	Tremfya療效及方便性皆優於Entyvio
萬芳	消化內科： 為提申請之科別，不另行詢問。	Tremfya與Entyvio相比是TNF antagonist治療失敗後更佳選擇。然而Tremfya 200mg與100mg尚無健保給付於此適應症 (Entyvio有)，完整療程花費昂貴，預期使用量少，建議可待健保價通過後，再行評估。
雙和	消化內科： 為提申請之科別，不另行詢問。	此劑量方便for induction使用 (原已有之Tremfya 100mg for maintenance)

綜合評估

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Tremfya 200mg/vial (Guselkumab)	否 (ATC碼相同，但劑型不同)	- Tremfya 100mg/1mL/pen - Entyvio 300mg/vial

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品 (新劑量、新劑型)	符合政策面特殊需求	符合醫療面特殊需求 (作為induction，讓院內 品項可用於IBD病人)
國內同儕使用經驗 (中山醫)	體系有使用經驗	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA		
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. 根據指引，經5-ASA、類固醇或免疫抑制劑治療失敗的中至重度克隆氏症與潰瘍性結腸炎病人，應該從biologic治療選項中，選擇高效價的藥物治療。 2. 體系內的 Anti-interleukin 類藥物(如 Tremfya 100mg/mL/pen、Skyrizi 150mg/mL/pen)，皆因劑型或劑量不適用為 induction，故只能用於乾癬或其他適應症。 3. 考量 Tremfya 200mg 可連帶擴增 Tremfya 100mg 的使用族群，提供IBD病人新的治療選擇，建議新進通過Tremfya 200mg，但不常備。			

建議通過	建議比價	建議不通過
不常備 		

新進藥品評估-案24

Omlyclo 150mg/1mL Pre-filled Syringe 休敏樂注射液劑150毫克/毫升



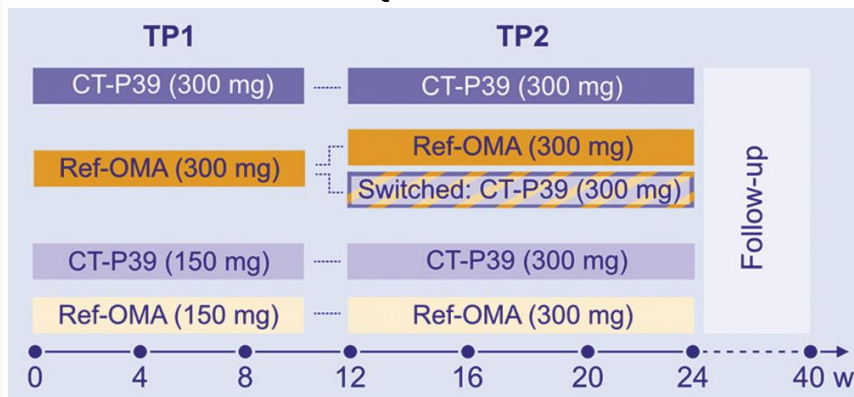
申請總表

藥名 (學名)	劑量/劑型	作用機轉	健保價/藥價	須取代藥品	同類藥品
Omlyclo (BS, Celltrion) (Omalizumab-BS)	150mg/mL Pre-filled Syringe	IgE antibody	7,026元	否 (第一個生物相似性 藥品)	Xolair 150mg syringe
衛福部適應症			申請理由(提藥醫師：雙和皮膚科 施怡賢醫師)		
- 過敏性氣喘附加療法：為附加療法用於改善已接受高劑量吸入性類固醇製劑及長效乙二型作用劑(β_2- agonist) 治療下仍有頻繁之日間症狀或夜間覺醒且具有多次重度氣喘惡化紀錄之重度持續過敏性氣喘成人、青少年及兒童(6 歲及以上)病人之氣喘控制。這些氣喘病人必須有經由皮膚測試或體外試驗顯示長期對空氣中過敏原呈陽性且肺功能降低($FEV_1 < 80\%$)。僅適用於證實為IgE 媒介型之氣喘病人。 - 慢性鼻竇炎併鼻息肉附加療法：適用於對鼻腔內皮質類固醇製劑治療無法達到適當的疾病控制之慢性鼻竇炎併鼻息肉成人(18 歲以上) 病人作為附加療法。適用於病人血清IgE 濃度有相對應建議的投與劑量。 - 慢性自發性蕁麻疹(Chronic Spontaneous Urticaria, CSU) 附加療法：適用於治療對H1 抗組織胺製劑治療反應不佳之慢性自發性蕁麻疹成人及青少年(12歲及以上) 病人作為附加療法。			Omlyclo為omalizumab生物相似藥，其療效、安全性及免疫原性與參考藥品Xolair®相當，可作為相同適應症之治療選擇。引進本藥可增加院內藥品選擇、提升供藥穩定性，並可望降低藥品支出及病人整體醫療負擔，故提出新藥申請。		

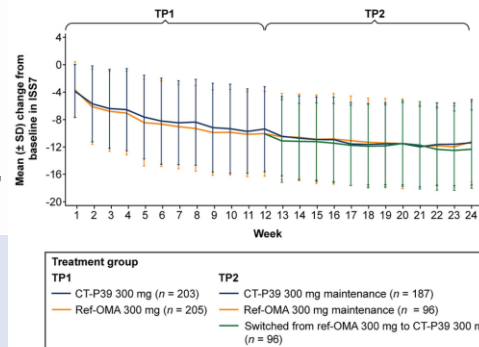
療效-文獻

Saini, et al. *Allergy*, 2025

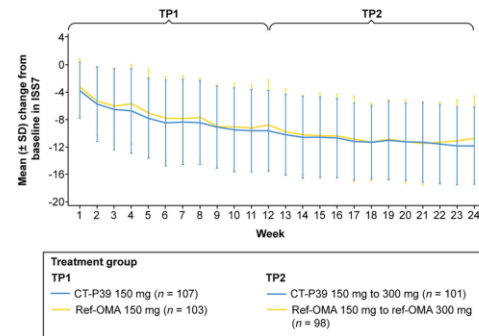
- Double-blind, randomized, active-controlled, parallel group, multicenter Phase 3 study
- Patients (n=619) aged 18 – 75 years with diagnosis of CSU of ≥ 6 months, ISS7 ≥ 8 points, UAS7 ≥ 16 points, to receive treatment Q4W



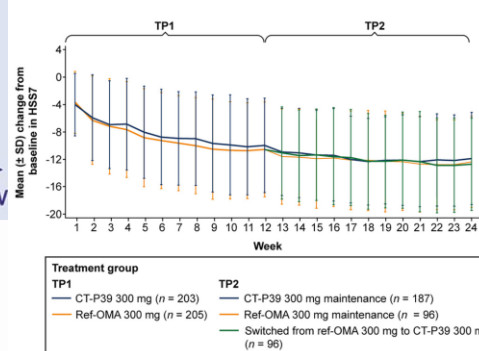
(A) Change in ISS7 with CT-P39 300 mg and ref-OMA 300 mg treatment



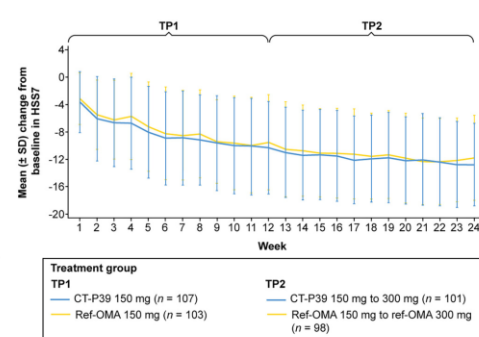
(B) Change in ISS7 with CT-P39 150 mg and ref-OMA 150 mg treatment



(C) Change in HSS7 with CT-P39 300 mg and ref-OMA 300 mg treatment



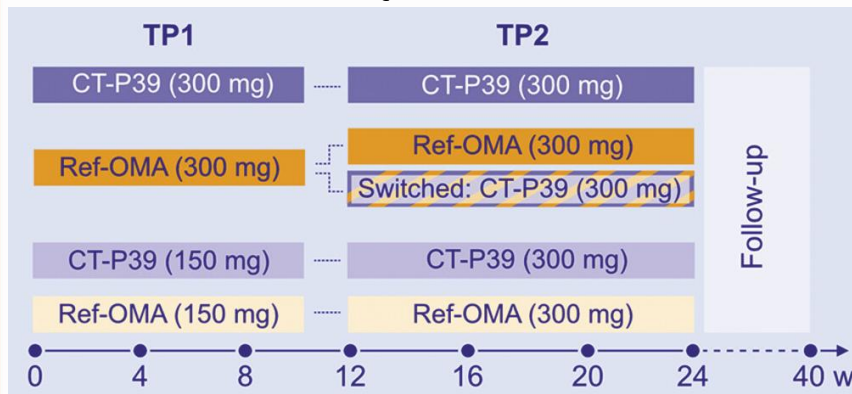
(D) Change in HSS7 with CT-P39 150 mg and ref-OMA 150 mg treatment



安全性

Saini, et al. *Allergy*, 2025

- Double-blind, randomized, active-controlled, parallel group, multicenter Phase 3 study
- Patients (n=619) aged 18 – 75 years with diagnosis of CSU of ≥ 6 months, ISS7 ≥ 8 points, UAS7 ≥ 16 points, to receive treatment Q4W



Patients, <i>n</i> (%)	Omlyclo 300 mg (<i>n</i> = 203)	Xolair 300 mg (<i>n</i> = 205)	Omlyclo 150 mg (<i>n</i> = 107)	Xolair 150 mg (<i>n</i> = 103)
≥ 1 TEAE	52 (25.6)	54 (26.3)	29 (27.1)	28 (27.2)
Treatment-related	9 (4.4)	14 (6.8)	6 (5.6)	9 (8.7)
≥ 1 TESAE	4 (2.0)	2 (1.0)	2 (1.9)	3 (2.9)
≥ 1 TEAE leading to drug discontinuation	3 (1.5)	2 (1.0)	0	0
≥ 1 TEAE leading to death	0	0	0	0
≥ 1 TEAE classified as allergic reaction type I/anaphylaxis	0	1 (0.5)	0	0
≥ 1 TEAE classified as ISR	5 (2.5)	9 (4.4)	1 (0.9)	3 (2.9)
≥ 1 TEAE classified as allergic reaction type III (serum sickness/serum sickness-like reactions)	1 (0.5)	0	0	0
≥ 1 TEAE classified as parasitic (helminth) infection	0	0	0	0
TE(S)AE: treatment-emergent (serious) adverse event; ISR: injection-site reaction				

醫療科技評估

Agency	Year	Key Findings
PBAC (Australia)	March 2026	- Under Section 101(4AACD) of the National Health Act 1953, Xolair and Omlyclo should be considered equivalent for substitution on the Schedule of Pharmaceutical Benefits - The recommendation was on a cost-minimisation basis and acknowledges that Omlyclo is not expected to provide a substantial and clinically relevant improvement in efficacy, or reduction of toxicity over Xolair, or not expected to address a high and urgent unmet clinical need given the presence of an alternative therapy.

同類藥品比較

	申請藥品	同類藥品
藥名	Omlyclo (BS, Celltrion) 150mg/mL syringe (Omalizumab-BS)	Xolair 150mg syringe (Omalizumab)
適應症	過敏性氣喘、慢性鼻竇炎併鼻息肉、慢性自發性蕁麻疹(Chronic Spontaneous Urticaria, CSU)	
角色	為生物相似性藥品，經第三期試驗證實在慢性自發性蕁麻疹的治療上，可與Xolair相互替代，取得與Xolair相同的適應症與可互換性(interchangeable)的資格	為原廠藥品，療效與安全性經臨床試驗佐證
建議劑量	- 過敏性氣喘、慢性鼻竇炎併鼻息肉：依體重和血清IgE濃度，給予75 – 600 mg Q2W or Q4W - 慢性自發性蕁麻疹：150 or 300 mg Q4W	
健保價	7,026 元	14,234 元
每日藥價	250.93 – 2007.43 元	508.36 – 4,066.86 元
月均用量	NA	316

臨床使用意見

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Omlyclo (BS, Celltrion) 150mg/mL (Omalizumab-BS)	否 (第一個生物相似性藥品)	Xolair 150mg syringe
主要開立科別：皮膚科		

	醫師意見	臨床藥師意見
附醫	皮膚科： 為提申請之科別，不另行詢問。	無意見，依臨床科意見為主
萬芳	皮膚科： 為提申請之科別，不另行詢問。	無意見，依臨床科意見為主
雙和	皮膚科： 為提申請之科別，不另行詢問。	適應症、年齡限制與劑型(預填syringe)等皆相同，具價格上優勢。惟室溫保存期限有差異。

綜合評估

申請藥品	暫定取代藥品	同類藥品
Omlyclo (BS, Celltrion) 150mg/mL (Omalizumab-BS)	否 (第一個生物相似性藥品)	Xolair 150mg syringe

文獻證明療效 相同或較優於現有藥品	文獻證明安全性 相同或較優於現有藥品	體系無作用類似之藥品	符合政策面特殊需求 (屬生物相似性藥品)	符合醫療面特殊需求
國內同儕使用經驗	體系有使用經驗	臨床需求共識度	價格/成本符合經濟效益	廠商供應穩定度及 企業永續作為或其他
高警訊	非高警訊藥品	LASA		
歷年審議結果 (年分/不通過原因)	無，首次申請			
綜合意見	1. Omlyclo有達成主要療效等效，證實其療效與原廠藥Xolair相當。 2. Omlyclo於試驗中，亦達成治療轉換(Switching)族群顯示療效維持性，並未引發額外安全風險，已取得可互換性(Interchangeable)資格，能替代原廠藥 Xolair。 3. 屬於生物相似性藥品，價格為Xolair的一半，需冷藏於2-8C，如放置於室溫不應超過7天(Xolair仿單建議不超過48小時)。 4. 考量上述，建議通過新進Omlyclo。			

建議通過	建議比價	建議不通過
✓		

新進細胞治療製劑評估-案25

自體脂肪幹細胞治療『退化性關節炎及膝關節軟骨缺損』

此案合作廠商	申請理由(提案PI：雙和骨科 陳致宇 醫師)
沛爾生技醫藥股份有限公司	- 目前院內「喜躍生醫」膝關節細胞治療展延案件已通過衛福部核准，但因實驗室製劑進行變更中，所以目前無法收案進行治療。 - 與「喜躍生醫」確認預計變更完成時間，廠商表示目前先送北醫案件進行變更，預計要到第三或第四季才能通過變更，雙和變更通過時間可能更晚!! 今年已有兩位病人進行詢問，但無法收案進行治療。 - 詢問多家廠商(包含萬芳醫院配合之「訊聯生技」)皆無回覆，唯沛爾生技表示願意合作

合作廠商比較	喜躍	沛爾
檢體採取方式	手術取脂肪	
適用病人族群	分級2~4	
施打次數	1	
細胞凍存	X	V (1年)
報價收費	單膝27.5萬/雙膝31.4萬	單膝27萬/雙膝30萬

療程摘要及技術

微創取脂

在局部麻醉下，由醫師自患者的腹部、臀部、大腿或膝關節周圍等皮下脂肪部位，微創抽取3 ~ 5克的脂肪組織

ADSC分離培養

- 自脂肪組織中分離出脂肪幹細胞進行體外分離與定量擴增(傳代次數 ≤ 5 次)，製備時間約需4-6週
- 最終製備出單劑 $1 \sim 10 \times 10^7$ 顆ADSC(懸浮於3mL生理食鹽水針筒中)

釋放生長因素

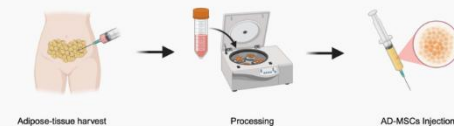
將單劑自體ADSC以局部麻醉方式注射至患側膝關節腔內，在關節腔內釋放生長因子以抑制發炎、調節關節環境，並分化為軟骨細胞，修復受損並增加軟骨體積

• 亮點優勢：獨家細胞凍存機制

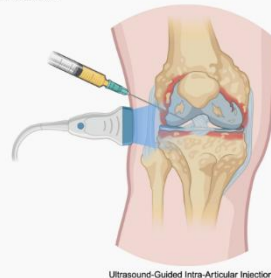
沛爾於首次培養時，可將剩餘之自體脂肪幹細胞凍存一年。若病患於6個月後需要追加治療，可直接解凍凍存細胞進行擴增，無需再次經歷抽脂手術。

*自體脂肪幹細胞(Autologous Adipose-derived Stem Cell, ADSC)

Cell Source and Preparation



Treatment Administration



標準治療療程 (Treatment Protocol)

1

啟動階段

共 1 次，共 1 劑
1~10 x 10⁷ ADSCs

2

療效評估

第 6 個月
主觀：WOMAC、VAS、KOOS、SF36
客觀：KSS、X-ray、MRI
主、客觀評估指標至少各達成一項

3

長期追蹤

療程結束後
應自接受最後一次再生醫
療技術起追蹤至少一年

總劑數：1 劑

*自體脂肪幹細胞(Autologous Adipose-derived Stem Cell, ADSC)

安全性監測與風險管理

監測機制

- 各階段
生命徵象、理學、血液/生化檢驗、醫師臨床評估表、患者自評表
- 篩選期～檢體採集期 (第-9~-4 週)
病史、病毒篩檢、女性妊娠試驗、影像學檢查
- 治療期～術後初期 (第 0~1 週)
治療紀錄、不良反應紀錄
- 術後追蹤期 (第1個月～第12個月)
治療後第六個月執行影像學檢查與療效指標評估、不良反應紀錄

不良反應

- 手術採取脂肪 (當天、術後)
 - 局部麻醉藥過敏
 - 傷口大量出血
 - 傷口感染
- ADSC 注射 (細胞治療後)
 - 發燒
 - 膝關節僵硬
 - 膝關節腫脹 (感染/非感染)
 - 關節腔血腫

目前收費明細

收費階段	收費項目	金額 (NTD) 單膝	雙和 (NTD) 分潤28%	廠商 (NTD)	金額 (NTD) 雙膝	雙和 (NTD) 分潤28%	廠商 (NTD)	收費時間
一	篩選期治療作業費	13,500	8,500	5,000	15,000	10,000	5,000	完成評估，確認進行療程日
二	採集檢體費、細胞處理費	108,000	33,000	75,000	120,000	35,000	85,000	採取脂肪檢體當日
三	第1次製備費及回輸治療費	113,400	18,400	95,000	126,000	21,000	105,000	細胞回輸當日
四	病人細胞治療後回診進行相關照護及檢查	8,100	2,700	5,400	9,000	3,000	6,000	細胞回輸後1~4週的回診
五	細胞治療品質成效費	27,000	13,000	14,000	30,000	15,000	15,000	細胞回輸後4個月的檢查
總計	全療程費用	270,000	75,600	194,400	300,000	84,000	216,000	-

- 第一階段及第二階段退費標準：無法生產符合規格之細胞製品，退還「檢體處理及培養費」(單劑型 NT\$66,000；雙劑型NT\$78,000)。
- 第三至五階段：依脂肪採集及培養天數

細胞治療案評分原則(參照精準委員會)

新案審查原則

- (1)體系同類細胞案件：至多2間廠商
- (2)既有案件於合約期間內無業務量者，不再續約
- (3)可單一院區提案引進，但需與既有項PK。



- (1)採血次數 (病人友善程度)
- (2)院方拆帳比 (院方利益)
- (3)適應症 (推展性)
- (4)收案量

評核指標 & 整合原則

- (1)同一細胞項保留2家廠商，超過時，評分較低者不建議持續合作
- (2)評分低於4分者，建議暫緩合作



- (1)收費過高(扣分)
- (2)無業務量者(扣分)

指標(共10分)	3分	2分	1分	0分
(1)採血次數	單次採血	1.血液分離術(單次) 2.採血1-2次	其它	
(2)院方拆帳比例	30%以上	25以上，未滿30%	20以上，未滿25%	20%以下
(3)適應症		涵蓋5種以上	涵蓋特殊適應症	5種以下(非特殊)
(4)收案量		1人/月以上	0.5~1人/月	未滿0.5人/月
(5)負項指標(扣分)	①②皆符合	①無業務量	②收費200萬以上	

評核結果	建議
5分以上	維持/通過
4~5分	觀察/討論
4分以下	暫緩

綜合評估

評分項目與分數	① 採血次數3分	② 拆帳比例3分	③ 適應症2分	④ 收案量2分	⑤ 負向指標扣3分
本項目評估得分	3分	2分	0分	0分	0分

類別	院區	PI	細胞治療	合作廠商	適應症	每案收費 (預計)	採血 次數	拆帳比 (目前報價)	業務量	評分	評分細項
新申請	雙和	陳致宇	自體脂肪幹細胞	沛爾	退化性關節 炎及膝關節 軟骨缺損	單膝27萬 雙膝30萬	1次	院拆28% 廠拆72%	尚無收案 (累計115/5)	5	① 3 ② 2 ③ 0 ④ 0 ⑤ 0
既有	附醫	李建和	自體脂肪幹細胞	喜躍	退化性關節 炎及膝關節 軟骨缺損	單膝31.4萬 雙膝33.25萬	1次	院拆35% 廠拆65%	19 (112/11/14- 114/11/14)	6	① 3 ② 2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 0
既有	萬芳	郭宜潔	自體脂肪幹細胞	訊聯	退化性關節 炎及膝關節 軟骨缺損	單膝31.4萬 雙膝33.25萬	1次	院拆41% 廠拆59%	21 (112/05/04- 115/05/03)	6	① 3 ② 2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 0

綜合意見

- 雙和既有廠商(喜躍膝關節細胞治療展延案件)已通過衛福部核准，但因實驗室製劑進行變更中，所以目前仍然無法收案進行治療。
- 雖體系內已有喜躍(但變更中)及訊聯兩家廠商，但一家變更中一家聯繫未果，且有病人預計使用，依細胞治療案評分原則，評分為5分，評估結果為「維持/通過」
- 考量上述，**建議通過雙和醫院與沛爾生技合作案-自體脂肪幹細胞治療『退化性關節炎及膝關節軟骨缺損』**

建議通過

建議比價

建議不通過

